FICHA ENTRENATZAILE

Alivia tu lumbago hoy

Qué te puede aliviar ahora mismo, qué no hacer y cómo saber si es tu lumbago de siempre

Esta ficha es un regalo para el día que te dé el tirón. Son cinco minutos: léela ahora con calma y guárdala o imprímela donde la encuentres, porque el día que la necesites no vas a querer buscarla.

ALIVIA TU LUMBAGO HOY

1. Treinta segundos antes de nada: ¿es tu lumbago de siempre?

> **Ve a urgencias hoy** si tienes cualquiera de estas:

- Dificultad nueva para controlar la orina o las heces.
- Entumecimiento en la zona genital o entre las piernas.
- Debilidad que va a más en una o las dos piernas.
- Dolor intenso tras una caída, un golpe fuerte o un accidente.

> **Pide cita con tu médico en los próximos días** si tienes:

- Dolor que baja por la pierna por debajo de la rodilla, con hormigueo, acorchamiento o pérdida de fuerza.
- Fiebre, malestar general o pérdida de peso que no te explicas.
- Dolor que no cede con ningún cambio de postura, que te despierta por la noche o que va a peor cada día.
- Un dolor que no se parece a tus episodios de siempre.

Si no tienes nada de esto y reconoces tu patrón (el tirón conocido, molesto pero mecánico), sigue. Y quédate con esto, que baja el miedo: **no te has roto nada. La espalda es fuerte. Esto se pasa.**

ALIVIA TU LUMBAGO HOY

2. Lo que te puede aliviar hoy

No hay un remedio que haga desaparecer el dolor, pero sí cosas que hacen el día más llevadero. Pruébalas y quédate con las que te funcionen a ti.

Calor

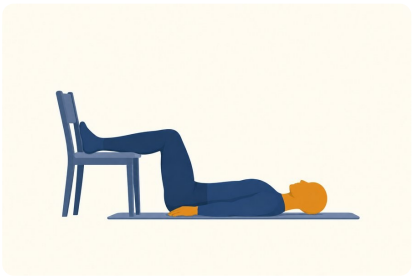
Es lo que mejor respaldo tiene para aliviar en los primeros días. Una bolsa de agua caliente, una manta eléctrica o un parche térmico sobre la zona lumbar, 15 a 20 minutos, varias veces al día.

- Pon una tela entre la fuente de calor y la piel.
- No te duermas con la manta eléctrica encendida.
- Calor que te resulte agradable, no que queme.

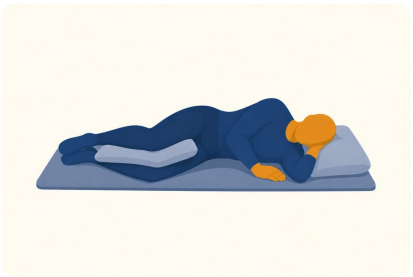
Posiciones de descanso

Cuando necesites parar un rato, estas posturas suelen aliviar. Prueba cada una unos minutos:

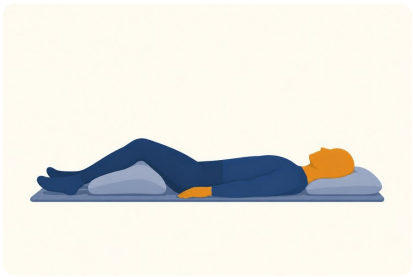
- **Tumbado boca arriba con las piernas sobre una silla o el sofá,** caderas y rodillas dobladas en ángulo recto.
- **De lado con una almohada entre las rodillas,** con las piernas ligeramente dobladas.
- **Boca arriba con una almohada bajo las rodillas.**



Piernas sobre una silla



De lado, almohada entre rodillas



Almohada bajo las rodillas

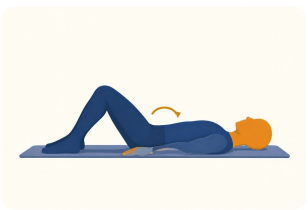
Descansar un rato en estas posturas está bien. Quedarte tumbado todo el día, no (lo explico abajo).

Seis movimientos suaves

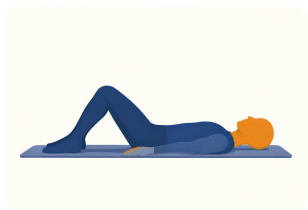
Estos movimientos no curan nada ni aceleran la recuperación. Lo que pueden hacer es reducir la rigidez y la sensación de bloqueo, y, sobre todo, mantener la espalda en movimiento sin asustarla.

> **Cómo probarlos:** haz 5 repeticiones lentas de cada uno, respirando con normalidad. Si te alivia o te deja igual, quédatelo y repítelo 2 o 3 veces al día. Si te aumenta el dolor o te lo lleva hacia la pierna, descártalo. A cada persona le alivian cosas distintas: a unas les va bien doblarse y a otras estirarse hacia atrás. No hay uno “correcto”.

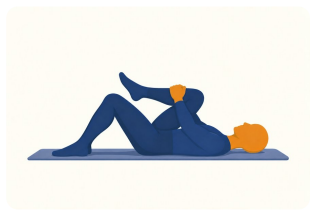
1. **Báscula pélvica.** Boca arriba, rodillas dobladas, pies apoyados. Aplana suavemente la zona lumbar contra el suelo y suelta. Un movimiento pequeño, sin forzar.
2. **Rodillas al pecho.** Boca arriba, lleva una rodilla hacia el pecho sujetándola con las manos, mantén unos segundos y cambia. Si te va bien, prueba con las dos a la vez.
3. **Balanceo de rodillas.** Boca arriba, rodillas dobladas y juntas. Déjalas caer suavemente hacia un lado y luego hacia el otro, sin llegar al suelo si molesta.
4. **Puente.** Boca arriba, rodillas dobladas. Sube la cadera unos centímetros apretando los glúteos y baja despacio.
5. **Gato-camello.** A cuatro patas. Redondea la espalda hacia el techo y luego déjala caer suavemente hacia el suelo. Rango pequeño al principio.
6. **Extensión tumbado.** Boca abajo, apoyado sobre los antebrazos, deja que la zona lumbar se relaje unos segundos y vuelve a bajar. Solo si te alivia; a algunas personas les va muy bien y a otras no.



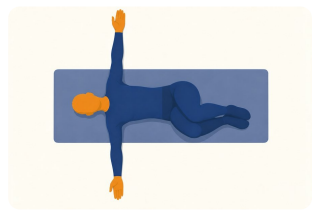
Hueco natural, y aplana...



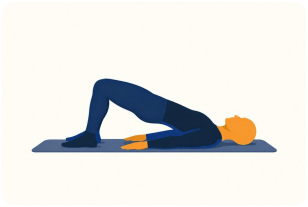
...hasta pegar la zona lumbar al suelo



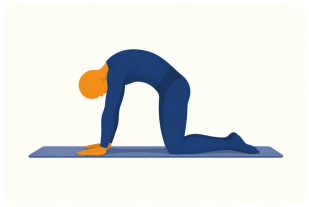
Rodilla al pecho



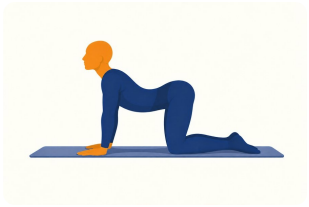
Balanceo de rodillas (vista desde arriba)



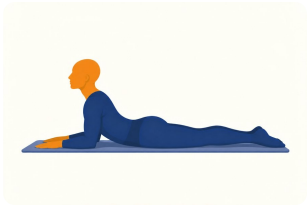
Cadera arriba



Gato: espalda hacia el techo



Camello: espalda hacia el suelo



Extensión sobre antebrazos

Caminar

Es lo más importante de todo, aunque no lo parezca. Paseos cortos de 5 a 10 minutos, varias veces al día, en llano y a ritmo cómodo. Dentro de casa también vale. El movimiento suave alivia y la quietud prolongada agarrota.

ALIVIA TU LUMBAGO HOY

3. Lo que no debes hacer

- **No te metas en la cama a esperar a que se pase.** El reposo prolongado alarga la recuperación y te agarrota. Descansa ratos, pero muévete entre medias.
- **No corras a hacerte una resonancia.** Sin señales de alarma, una prueba de imagen no mejora nada y suele encontrar “hallazgos” (desgastes, protrusiones) que tiene casi todo el mundo sin dolor.
- **No fuerces un movimiento que dispara el dolor “para soltarlo”.** No suelta nada. Muévete dentro de lo que toleras.
- **No busques el estiramiento mágico.** No hay nada que “recoloque” la espalda. Lo que alivia hoy es comodidad, no curación.

ALIVIA TU LUMBAGO HOY

4. Lo que esto hace y lo que no

Todo lo anterior hace que el episodio sea más llevadero. No hace que dure menos. La mayoría de los episodios mejoran mucho en unas semanas, hagas lo que hagas en estos primeros días.

Lo que sí depende de ti es lo que viene después: cómo vuelves a moverte, a cargar y a doblarte, y si usas esta recuperación para que el siguiente episodio tarde más en llegar o dejas que se repita el ciclo de siempre. Eso lo explica la guía que acompaña a esta ficha, *Por qué tu espalda vuelve a fallar*.

> **Si quieres que lo miremos para tu caso:** la Hoja de Ruta es una valoración de tu situación y un plan escrito con tus prioridades, pensado para que lo cumplas en tu vida real.

Conoce la Hoja de Ruta en entrenatzaile.alainzulaika.com/hoja-de-ruta →

Fuentes: American College of Physicians, guía de tratamientos no invasivos del dolor lumbar (Annals of Internal Medicine, 2017): el calor superficial tiene evidencia de calidad moderada para el alivio a corto plazo en el dolor lumbar agudo. French SD et al., Cochrane 2006, sobre calor y frío superficial. NICE NG59 (2016, actualizada 2020): mantenerse activo y señales de alarma. Los movimientos suaves se proponen como forma de movimiento tolerable; no hay evidencia de que acorten el episodio.

Contenido educativo. No sustituye la valoración de un profesional sanitario. Si tu médico te ha pautado algo para estos episodios, sigue sus indicaciones.